



La première édition du Congrès International de Biologie Médicale de Sétif (CBMS) : 24/25 octobre 2026
Faculté de médecine UFAS-1 / CHU de Sétif



Profil bactériologique des infections du pied diabétique et étude de la sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées.

R. MEKAHLIA ^a, L. MEKAHLIA ^b, Y. MANCERI ^a

^a Laboratoire central de biologie médicale , unité de microbiologie, Etablissement Public Hospitalier El Hadjar, Annaba

^b Laboratoire de Chimie Minérale, Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Annaba

E-mail: radiamekahlia@gmail.com

Introduction

Les ulcérations du pied diabétique (UPD) affectent environ 25% des patients diabétiques et s'infectent dans 40 à 80% des cas [1]. La résistance aux antibiotiques, notamment les Bactéries Multirésistantes (BMR), aggrave le pronostic, complique les traitements et augmente considérablement le risque d'imputation.

Objectif

Cette étude vise à caractériser le profil bactériologique des infections du pied diabétique et à identifier la sensibilité et la résistance aux antibiotiques des bactéries isolées ; chez les patients hospitalisés au niveau de l'EPH Elhadjar- Annaba, afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique.

Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude rétrospective effectuée au niveau de l'unité de microbiologie , portant sur les prélèvements réalisés chez des patients présentant des UPD, durant la période qui s'étale du 1er janvier au 30 juin 2026.

L'identification des souches bactériennes a été réalisée par des techniques conventionnelles. L'étude de la sensibilité aux antibiotiques a été effectuée conformément aux recommandations du CLSI, et l'exploitation des données a été réalisée à l'aide du logiciel WHONET 5.6.

Résultat et Discussion

Durant la période d'étude, 29 prélèvements positifs ont été recueillis chez des patients dont le sexe ratio H/F égale à 2.33, dont 70% des infections sont polymicrobiennes. Au total, 37 bactéries ont été isolées : *Staphylococcus aureus* est le prédominant (33%), suivi de *Proteus mirabilis* (31%), *Escherichia coli* (20%), *Klebsiella spp* (6%), *Pseudomonas aeruginosa* (5%), *Entérobacter spp* et *streptococcus spp* (4% pour chacune). A noter que, 80% des infections monomicrobiennes sont causées par le *Staphylococcus aureus*.

Conclusion

Les infections du pied diabétique présentent une flore bactérienne variée, souvent polymicrobienne. Les infections aiguës sont causées principalement par des cocci Gram positif (*Staphylococcus aureus*), alors que les formes chroniques et sévères associent fréquemment des bacilles Gram négatif (*Proteus mirabilis*). Les résultats de notre étude sur les UPD soulignent la nécessité d'une prise en charge rapide, d'un prélèvement fiable et d'une antibiothérapie ajustée selon l'antibiogramme pour prévenir les complications évolutives.

Références:

- Armstrong DG (ed). Clinical care of the Diabetic Foot. 4eme édition. American Diabetes Association, 2024.
- Veves A, Giurini JM, Schermerhorn ML(eds). The Diabetic Foot : Medical and Surgical Management. 5eme édition. Springer, 2024.

■ Infections monomicrobiennes
■ Infections polymicrobiennes

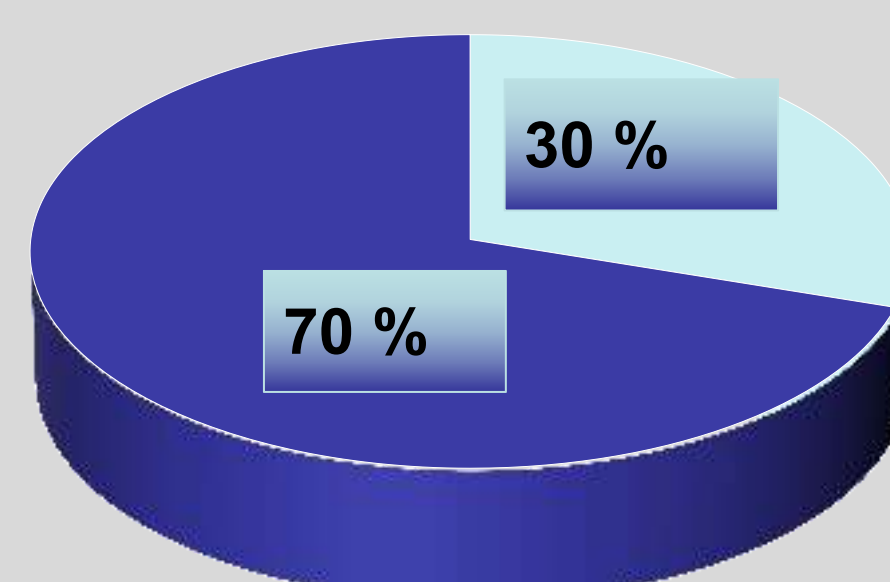


Fig 1: Types des infections du pied diabétique

■ *Staphylococcus aureus*
■ *Escherichia coli*
■ *Pseudomonas aeruginosa*
■ *Streptococcus spp*
■ *Proteus mirabilis*
■ *Klebsiella spp*
■ *Entérobacter spp*

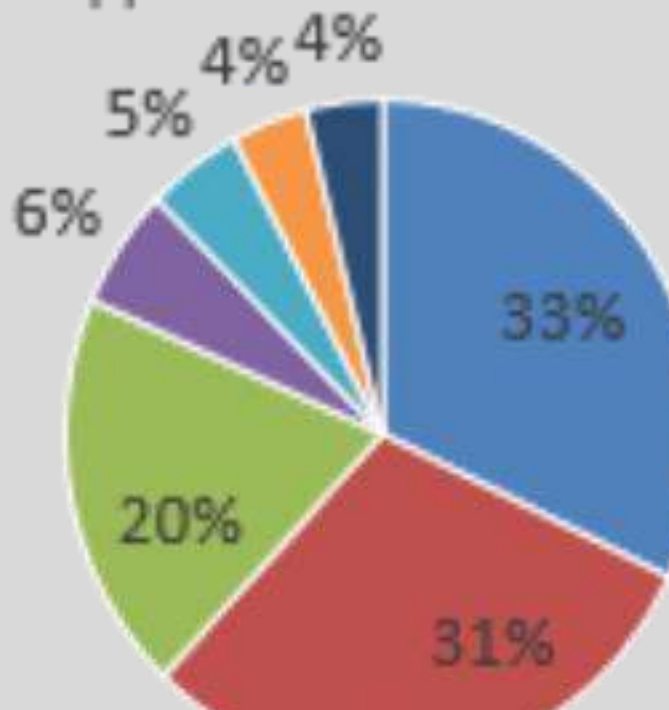


Fig 2: Répartition des principales espèces isolées

Ces résultats concordent avec des études récentes mettant en évidence la prédominance des cocci Gram positif, en particulier *Staphylococcus aureus*, dans les infections du pied diabétique [2].

Les résistances aux antibiotiques chez les souches de *Staphylococcus aureus* et *Proteus mirabilis* retrouvées sont représentées sur le tableau 1 et 2 :

Tableau 1 : Profil de résistance des souches de *Staphylococcus aureus*

Antibiotique	%
Céfotaxime	57
Ciprofloxacine	62
Sulfaméthoxazole-triméthoprim	56
Amikacine	05
Acide fucidique	78
Vancomycine	0
Fosfomycine	02
Pristinamycine	05

Tableau 2 : Profil de résistance des souches de *Proteus mirabilis*

Antibiotique	%
Amoxicilline-acide clavulanique	89
Céfotaxime	65
Imipénème	02
Gentamycine	36
Ciprofloxacine	54
Sulfaméthoxazole-triméthoprim	67